

이 검사는 신장에서 방광으로 소변을 운반하는 관인 요관(ureter)을 마취 상태에서 자세히 살펴보는 검사입니다. 집도의는 여러 방법을 조합하여 협착(narrowing)의 정확한 위치와 길이를 파악하고 적절한 수술을 계획합니다.

이 검사에 대하여

요관의 협착(stricture)은 외부에서 측정하기 어려워, 집도의가 마취 중 직접 확인합니다. 필요에 따라 다음 검사를 **하나 또는 여러 가지** 조합하여 시행합니다.

- **진단 요관경(ureteroscopy)** — 가는 유연 내시경을 요관 안으로 넣어 직접 관찰합니다.
- **역행성 신우조영술(retrograde pyelogram)** — 방광에서 요관으로 조영제(contrast)를 주입한 후 X선을 촬영합니다.
- **순행성 신우조영술(antegrade pyelogram)** — 신장 배액관이 있는 경우, 위쪽에서 조영제를 흘려 협착 부위를 확인합니다.
- **방광경/방광조영술(cystoscopy/cystogram)** — 방광 내부를 관찰하고 X선 사진을 촬영합니다.

검사 목적은 협착의 위치·길이·정도를 정확히 파악하는 것입니다. 같은 날 요관 스텐트(stent) 또는 신장 배액관을 삽입하거나 교체할 수 있습니다.

안전한가요?

네. 흔히 시행하는 저위험 검사입니다. 대부분의 환자는 검사 후 일시적인 혈뇨, 가벼운 배뇨 시 따가움, 또는 옆구리 통증을 경험합니다. 드물게 요로감염(UTI)이나 요관 자극이 생길 수 있으며, 요관 손상은 매우 드뭅니다. 마취는 일반적으로 매우 안전합니다.

용어 설명

요관(Ureter)

신장에서 방광으로 소변을 운반하는 관입니다.

협착(Stricture)

흉터로 인해 좁아진 부위로, 소변 흐름을 느리게 하거나 막습니다.

요관경(Ureteroscopy)

가는 유연 내시경으로 요관 내부를 직접 관찰하는 검사입니다.

역행성 신우조영술

방광에서 위쪽으로 조영제를 주입한 뒤 촬영한 X선 영상입니다.

순행성 신우조영술

신장 배액관을 통해 아래쪽으로 조영제를 주입한 뒤 촬영한 X선 영상입니다.

신루관(Nephrostomy tube)

등을 통해 신장을 배액하는 관으로, 조영제를 주입하는 데 사용할 수 있습니다.

조영제(Contrast dye)

X선에서 하얗게 보이는 액체로, 요관 내부를 시각화합니다.

요관 스텐트(Stent)

요관을 열어두는 부드러운 내부 튜브로, 삽입하거나 교체할 수 있습니다.

아픈가요? 마취 상태에서 진행하므로 검사 중에는 아무것도 느끼지 않습니다. 검사 후 1~2일 동안 가벼운 배뇨 시 따가움, 둔한 옆구리 통증, 또는 혈뇨가 있을 수 있습니다. 짧은 시술이며 대부분 당일 귀가합니다.

준비 방법 (검사 전)

- 이 검사는 **마취** 하에 시행됩니다 — 금식 및 복용 약물(혈액희석제 포함) 중단 지침을 반드시 따르세요.
- **소변 검사**로 감염 여부를 확인합니다 — 활동성 감염이 있으면 먼저 치료해야 합니다.
- 현재 삽입된 **신루관 또는 요관 스텐트**는 그대로 유지하고, **귀가를 위한 동반자를 미리 준비**하세요.

다음 사항은 **사전에** 의료진에게 알려주세요:

- **X선 조영제 또는 요오드**에 반응한 적이 있는 경우
- **혈액희석제**를 복용 중이거나, **요로감염 증상**이 있는 경우

진행 과정

- 1 마취 후 항생제를 투여합니다.
- 2 방광경을 방광 안으로 넣고, 요관에 조영제를 주입하며 X선을 촬영하거나 내시경을 요관 안으로 넣어 관찰합니다.
- 3 신루관이 있는 경우, 위쪽에서 조영제를 흘려 협착 부위를 양방향으로 확인할 수 있습니다.
- 4 결과를 정리하고, 필요 시 요관 스텐트 또는 신루관을 삽입하거나 교체합니다.

후

- 마취에서 회복한 후 보통 **당일 귀가**합니다(동반자 필요).
- 1~2일 동안 **가벼운 따가움, 옆구리 통증, 또는 분홍빛 소변**이 있을 수 있습니다. 물을 충분히 마시면 도움이 됩니다.
- 요관 스텐트를 삽입한 경우 **절박뇨나 가벼운 불편감**은 정상입니다.
- 집도의가 검사 결과를 검토하고 수술 계획을 설명합니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열 또는 오한
- 심하거나 악화되는 옆구리 또는 복부 통증
- 심한 출혈, 또는 소변 내 혈전
- 소변을 보기 어려움, 또는 지속적인 구역·구토

기억할 세 가지

1. 이 검사는 마취 중 내시경과 조영제를 이용해 요관 협착의 위치·길이를 정확히 파악하고, 수술을 계획하기 위한 검사입니다.
2. 마취를 사용하므로 금식·약물 지침을 따르고, 감염이 있으면 먼저 치료하며, 신루관·스텐트는 그대로 유지하고, 귀가 동반자를 준비하세요.
3. 대부분 당일 귀가합니다. 1~2일간 가벼운 따가움·옆구리 통증·혈뇨는 정상입니다 — 물을 충분히 마시고, 발열·심한 통증·심한 출혈이 있으면 즉시 연락하세요.